Ospedale Sant'Ambrogio di Roccalta
Dipartimento di Neuroscienze
S.C. Neurologia - Stroke Unit
Direttore: Prof. Giorgio Locatelli

Viale Piave 43
24047 Treviglio
Stroke Unit 0363 424715

Egregio Dott. Enrico Bonfanti
Medico di Medicina Generale
Seriate

Lettera di dimissione

Stroke Unit - ricovero in regime ordinario

DATI DEL PAZIENTE

Paziente:	**GALIMBERTI ROBERTO**	Nato il:	**09/09/1966**
Codice fiscale:	**GLMRRT66P09A794M**	Residente:	**Via Paderno 27, Seriate**
SDO n.:	**A25/0047731**	Cartella:	**NEU-25-000614**
Ammissione:	**17/03/2025 ore 10:12**	Dimissione:	**25/03/2025**

SDO: A25/0047731

Caro Collega,
Ti scriviamo in merito al Tuo assistito sig. Roberto Galimberti, di 58 anni, giunto in PS il 17 marzo u.s. con attivazione del percorso Code Stroke, per emiparesi destra e afasia motoria insorte alle ore 8:40 durante la colazione. L'esordio è stato riferito dalla moglie, sig.ra Laura Cattaneo, presente all'evento.

Anamnesi patologica remota

Ipertensione arteriosa in trattamento irregolare. Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno non trattata. Fumatore attivo (20 sigarette/die). Non allergie note. Familiarità positiva per ictus (padre).

Decorso clinico

All'arrivo NIHSS 9, PA 178/96 mmHg, peso stimato 82 kg. La TC encefalo senza mdc escludeva lesioni emorragiche (ASPECTS 8); l'angio-TC non mostrava occlusioni di grosso vaso. Alle ore 09:55 è stata eseguita trombolisi sistemica con alteplase 0,9 mg/kg (dose totale 74 mg), senza complicanze emorragiche. A 24 ore NIHSS 4, alla dimissione NIHSS 2 per lieve deficit di forza alla mano destra e minime difficoltà di denominazione.
Il monitoraggio ECG continuo ha documentato in terza giornata un episodio di fibrillazione atriale parossistica della durata di circa 6 ore, confermato all'Holter. Dopo controllo neuroradiologico, in quinta giornata è stata avviata terapia anticoagulante orale. Valutazione logopedica a cura della dott.ssa Silvia Mapelli: deglutizione sicura, afasia in rapido miglioramento.

Indagini strumentali

Esame	Data	N. accesso	Esito sintetico
TC encefalo + angio-TC	17/03/2025	RX2503170231	Non emorragie, non occlusioni di grosso vaso
RM encefalo	19/03/2025	RM2503190088	Lesione ischemica acuta cortico-sottocorticale frontoinsulare sinistra
ECG Holter 24 h	20/03/2025	HO2503200019	FA parossistica, FC media 84 bpm

Diagnosi di dimissione

Ictus ischemico cardioembolico in territorio dell'arteria cerebrale media sinistra, trattato con trombolisi sistemica. Fibrillazione atriale parossistica di nuova diagnosi (CHA2DS2-VASc 3). Ipertensione arteriosa. Alla dimissione mRS 1 (scala di Rankin modificata).

Terapia alla dimissione

Farmaco	Dose	Orari	Note
Apixaban 5 mg	1 cpr	ore 8 e ore 20	non sospendere senza parere medico
Atorvastatina 40 mg	1 cpr	ore 21	
Amlodipina 5 mg	1 cpr	ore 8	obiettivo PA < 130/80
Perindopril 5 mg	1 cpr	ore 8	
Vareniclina 0,5 mg	1 cpr	secondo schema	supporto alla cessazione del fumo

Follow-up

Visita neurologica: a 6 settimane presso il nostro ambulatorio (prenotazione P25-118804)

Logopedia: ciclo di 10 sedute presso il servizio di riabilitazione territoriale

Polisonnografia: da programmare tramite CUP per sospette apnee notturne

Si raccomanda l'astensione dalla guida per almeno 30 giorni. Il paziente e la moglie, sig.ra Cattaneo, sono stati istruiti sul riconoscimento dei segni di allarme (scala FAST) e sull'assunzione dell'anticoagulante.

Il Dirigente Medico

Dott.ssa Chiara Pesenti

NEUROLOGIA - STROKE UNIT
Dott.ssa Chiara Pesenti
Iscr. Albo BG n. 8127

Treviglio, 25-03-2025

Il Direttore

Visto per la dimissione

Prof. Giorgio Locatelli